

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל הגבלה גופנית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי מספר: 03-01-04-03			
הספר: 03, שרותי סיעוד		התחום: 01, קבלת חולים שחרור העברה והשהייה	
הנושא: 04, השהיית חולה באשפוז		הנוהל: 03, הגבלה גופנית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי	
מהדורה: שישית		עדכון ופרסום: נובמבר 2024	עמוד 1 מתוך 7
הנוהל עודכן ע"י: פנינה שרון מנהלת חטיבה			
הנוהל לאישור ע"י (לפי א"ב): דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, ד"ר תמר אלרם מנהלת ביה"ח ה"צ, פרופ' קובי אסף לשכה משפטית, פרופ' יניב שרר מנהל ביה"ח הדסה ע"כ.			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה מרכזת תחום נהלים מוסדית וכלל ארגונית המערך לאיכות ובטיחות			
תחומי האקדמיטציה: COP 3 (JCI מהדורה 7)			
המסמך מתייחס לנשים ולגברים כאחד			

1. סימוכין

- חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו תשנ"ד 1994.
- חוק זכויות החולה תשנ"ו 1996.
- חוזר מנהל רפואה, בנושא: [נוהל להגבלה פיסיית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי](#), מספר: 15/2009.
- חוזר מנהל הסיעוד, בנושא: [ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי](#), מרץ 2022.
- חוזר מנהל הסיעוד, בנושא: [מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות](#), מספר: 104/14.

2. נספחים

- נספח 1: [תכנית טיפול יעודית הכוללת אומדן ותייעוד](#).
- נספח 2: [עדכוני הנוהל](#).

3. מבוא

הגבלה גופנית מהווה אמצעי טיפול שמטרתו להגן על המטופל מפני גרימת נזק לעצמו ולזולתו. פעולה טיפולית זו, המסתמכת על שיקול דעת מקצועי, תבוצע רק לאחר שמוצו כל האפשרויות הטיפוליות החלופיות, תוך שמירה על זכויות וכבוד המטופל.

הקושי בהגבלה פיסיית מתעורר לגבי מטופלים שאינם יכולים לתת את הסכמתם המודעת להגבלה ואין להם אפטרופוס על גופם. במקרים אלה בהסתמך על סעיף 15.1 וסעיף 15.3 לחוק זכויות החולה ניתן לתת טיפול רפואי לרבות הגבלה גופנית, ללא הסכמת המטופל/בא כוחו/האפטרופוס.

נוהל זה חל על מקרים בהם החולה שלא מדעת עלול לפגוע בעצמו ו/או בזולתו, אם לא תוגבל תנועתו. בנוהל זה נקבע כי החלטה על הגבלה פיסיית יכולה להתקבל גם על ידי אחות מוסמכת אחראית משמרת.

נוהל זה אינו מתייחס להגבלה גופנית של חולי נפש כמפורט בחוק לטיפול בחולי נפש ותקנותיו (חוק הטיפול בחולי נפש התשנ"א, 1991).

נוהל זה אינו מתייחס לכבילת מאושפזים הנמצאים במשמורת של גורמי ביטחון כמו משטרה או שרות בתי הסוהר.

4. מטרה

- 4.1. להבטיח שימוש באמצעי קשירה להגבלת מטופל, באופן שקול ומבוקר, תוך שמירה על בטיחותו, שלומו וכבודו של המטופל.
- 4.2. להגדיר את תהליכי המעקב, הטיפול והתיעוד הנדרשים אצל מטופל הנמצא בהגבלה פיסיית או ייצוב.

5. חלות

נוהל זה חל על צוות רפואי וסיעודי בבתי החולים של הדסה.

6. סמכות ואחריות

6.1. רופא ואחות מוסמכת אחראית משמרת

- 6.1.1. קבלת החלטה בדבר הגבלה פיזית של מטופל לשם מתן טיפול רפואי.
- 6.1.2. חידוש ההוראה בדבר הגבלה פיזית למשך 8 שעות נוספות ועד ל- 24 שעות רצופות.
- 6.1.3. קבלת החלטה בדבר התרת ההגבלה הפיזית של מטופל.
- 6.1.4. באחריות הרופא / האחות נותני ההוראה על הגבלה פיזית להסביר למטופל /לאפוטרופוס /לבא כוחו או לבן משפחתו, על הצורך בהגבלה, וקבלת הסכמה במידת האפשר.
- 6.1.5. באחריות הרופא או האחות שהחליטו על הגבלה גופנית, לתעד את סיבות בצו ההגבלה וההתרה ברשומת המטופל.
- 6.1.6. באחריות הרופא או האחות שהחליטו על הגבלה גופנית, ליידע את מנהל המחלקה/רופא מטעמו/אחות ראשית/מנהלת תורנית/מנהלת חטיבה בסמוך ככל האפשר למועד ההחלטה, ולתעד את הדיווח.
- 6.1.7. באחריות האחות המטפלת לבצע אומדן כל שעותיים מרגע תחילת ההגבלה הפיזית.
- 6.2. מנהל המחלקה או רופא מטעמו
- 6.2.1. מתן אישור לביצוע הגבלה של המטופל לפרקי זמן רצופים העולים על 24 שעות.

7. הגדרות

- 7.1. "הגבלה גופנית של מטופל": הגבלת חופש התנועה על ידי שימוש באביזרים ייעודיים. קשירת גפה/גפיים, ו/או גוף החולה, אל מסגרת המיטה, במטרה להגביל את תנועתו, על מנת למנוע אפשרות לנזק עצמי או לזולת.
- 7.2. "ייצוב תנוחת המטופל": שימוש באביזרים ייעודיים המייצבים את תנוחת המטופל במיטה/ בכיסא ו/או כיסא גלגלים. קשירת גוף החולה לכורסא על מנת לייצב את ישיבתו ולמנוע את אפשרות החלקתו ונפילתו.
- 7.3. "אפוטרופוס": מיופה כוחו של החולה לפי קביעת שופט.
- 7.4. "בא כוח": אדם שהחולה מינה בכתב ובחתימתו להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי.
- 7.5. "בן משפחה": בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבתא, מאמץ, מאומץ.
- 7.6. "אחות": אחות ראשית או אחראית משמרת.
- 7.7. "רופא מטפל": רופא מחלקתי, המכיר את החולה ונמנה על הצוות המטפל.
- 7.8. "אומדן": בדיקה המבוצעת על ידי האחות במגמה למנוע סיבוכים ולבדוק את הצורך בהמשך / התרת ההגבלה הגופנית.
- 7.9. "מצב חרום רפואי": נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידיית לחייו או קיימת סכנה מיידיית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לאייתן טיפול רפואי דחוף.

8. שיטה

8.1. החלטה בדבר הגבלה פיזית של מטופל

- 8.1.1. ככלל בדומה לעקרונות החלים על כל טיפול רפואי, נדרשת הסכמת החולה או האפוטרופוס, בא כוחו, או הוראת דין, המאפשרת לטפל באדם ללא הסכמתו, כך גם לפני ביצוע הגבלות תנועתיות.
- 8.1.2. אם ניתן לקבל את הסכמת החולה או האפוטרופוס שלו להגבלה גופנית, קיימת חובה לקבל הסכמה.
- 8.1.3. למרות שיש צורך וחשיבות ליידע את קרובי המטופל המלווים אותו בזמן האשפוז בדבר ההגבלה.



הפיסית, אין בסמכותם של קרובים אלה לתת הסכמה לטיפול רפואי ו/או הגבלה גופנית. הסכמה יכולה להינתן רק ע"י מי שמונה כאפטרופוס על פי דין או ע"י בא כוחו של החולה לפי "חוק זכויות החולה" (1996).

8.1.4. הגבלה גופנית ללא הסכמה מדעת תופעל כאשר אין אפשרות לקבל את הסכמת החולה; בא כוחו של החולה; אפטרופוס של החולה אם הוא קטין או פסול דין ולא ידוע למטפל כי החולה או האפטרופוס מתנגדים לקבלת הטיפול.

8.1.5. הגבלה תבוצע רק לאחר שניסיונות חלופיים לקשירה נכשלו, כדוגמת: הרגעה מילולית, הסברים וניסיונות להשיג שיתוף פעולה עם החולה, מתן תרופות הרגעה סיוע מבן משפחה, ידידים, או מלווים המצויים ליד מיטת החולה.

8.1.6. במקרים בהם מלווה המטופל בבני משפחה, או אחרים המסוגלים ומוכנים להשגיח עליו, יש לשקול הימנעות מהגבלה פיסיית, הכל בהתאם לנסיבות.

8.1.7. הפעלת הגבלה גופנית תבוצע לחולים המתנגדים לטיפול במצב חירום רפואי, מנסים לשלוף צנרת או עלולים לחבל

בטיפול הניתן להם, בעצמם ו/או באחרים ובמצב בו אינם שולטים על התנהגותם.

8.2. מצבים המצריכים הגבלה גופנית של חולה

8.2.1. החולה עלול לסכן פיסיית את עצמו או את הזולת.

8.2.2. החולה מקבל טיפול שעלול להביא לשינוי פתאומי במצבו (כגון: בשלבי התעוררות מהרדמה, או לאחר ניסיון אובדני וסכנה פיסיית לעצמו או לזולת).

8.2.3. החולה במצב של אי שקט פסיכומטורי או במצב בלבולי/במצב של חוסר התמצאות בזמן ובמקום, וקיימת סכנת עזיבה או יציאה לא מבוקרת מהמחלקה.

8.2.4. מטופל עם פגיעה במצב ההכרה (בלבול, אי שקט), מטופל שעלול לפגוע בעצמו באקראי ולא בכוונה ובאמצעי הטיפול בו - כמו הוצאת צנרת.

8.2.5. חולה שאינו מסוגל לשלוט בגופו לשם יציבות וישיבה.

8.2.6. מטופל המתנגד לטיפול המבוצע על פי סעיף 15.3 לחוק זכויות החולה.

8.3. הליך ביצוע הגבלה גופנית לחולה

8.3.1. זיהוי הצורך בהגבלה ע"י אחות או רופא.

8.3.2. הרופא/האחות יבצעו אומדן מצב המטופל וברור הסיבה להתנהגות.

8.3.3. הרופא/האחות יבחנו ויעריכו אפשרויות טיפוליות אחרות להרגעת החולה: הרגעה מילולית, טיפול תרופתי, סיוע בן משפחה וכד'.

8.3.4. מתן הסבר למטופל במידת האפשר, לאפטרופוס/לבא כוחו או לבן משפחתו על הצורך בהגבלה, וקבלת הסכמה במידת האפשר.

8.3.5. ההגבלה הפיסיית תתבצע באופן בטיחותי שתאפשר לחולה נוחות מרבית, חופש תנועה ככל האפשר ומניעת סיבוכים. ההגבלה תתבצע בעזרת ציוד ייעודי המתאים למטרה זו.

8.3.6. הגבלת הגפיים תבוצע באופן שימנע סיבוכים או נזק בגין שימוש ברצועות בד חזקות ומרופדות, תוך שמירה מפני פגיעות בעור ו/או חסימה באזור החיכוך. לילדים קטנים תעדיף האחות הגבלת הגפה באמצעות Boxing Gloves.

8.3.7. האחות תימנע מקשירת פרק כף היד/קרסול לחולים עם עירוי, או שנט לדיאליזה באזור.

8.3.8. רצועות יקשרו אל מסגרת מיטה ולא אל דפנותיה להגנה על הגפיים בעת הורדת הדפנות.

8.3.9. האחות תקפיד על השכבת החולה בתנוחה המבטיחה תפקוד גופני תקין, תוך מתן תמיכה לאיבר



הקשור.

8.3.10. בכל שלבי ביצוע ההגבלה ישמרו שלומו וכבודו של החולה.

8.3.11. האחות תעדיף למקם חולה קשור בטווח ראייתה ושמיעתה.

8.3.12. האחות תבטיח אפשרות קריאה של המטופל לאיש צוות (כמו פעמון).

8.3.13. בחדר בו נמצא החולה יהיו סידורי בטיחות נאותים, אוורור סביר, גלאי עשן וריהוט הכרחי בלבד. יש להרחיק מטווח ידו של החולה אביזרים שעלולים לסכנו. יש למנוע גישה חופשית של זרים לחולה המוגבל.

8.3.14. האחות תשייך תכנית טיפול יעודית הכוללת אומדן ותיעוד (נספח 1) מיד עם הפעלת הגבלה.

8.4. בטיחות החולה המוגבל

8.4.1. בתחילת כל משמרת תבצע האחות אומדן הצורך בהמשך ההגבלה.

8.4.2. האחות תפעל לפי תכנית הטיפול היעודית (נספח 1).

8.4.3. האחות תבצע אומדנים נוספים על פי מצב המטופל ועמידה בתכנית הטיפול הייחודית שלו

8.4.4. האחות אחראית כל שעותיים לביצוע טיפול סיעודי: שינוי תנוחה, שחרור הגפיים המוגבלות ומניעת סיבוכים תוך דאגה לנוחותו ורווחתו של המטופל.

8.4.5. איש צוות יבקר את החולה מדי חצי שעה לפחות, כדי לענות לצרכיו הבסיסיים והמידיים (נספח 1).

8.4.6. מטופלים בהכרה מלאה, המסוגלים לקרוא לאיש צוות בכל עת, ניתן להסתפק בביקור איש צוות אחת לשעה.

8.5. משך הזמן לביצוע הגבלה גופנית

8.5.1. תוקפה של הוראה להגבלה גופנית ע"י אחות אחראית משמרת/רופא מוגבל ל- 8 שעות.

8.5.2. ההוראה תחודש אחת ל- 8 שעות לפחות ע"י רופא מטפל, בהעדרו של הרופא המטפל ע"י רופא אחר או אחות אחראית משמרת.

8.5.3. אין להגביל את החולה לפרק זמן העולה על 24 שעות ללא אישור מנהל המחלקה או מי מטעמו.

8.6. ייצוב תנוחת חולה בישיבה

8.6.1. קיימת קבוצת חולים שתכנית הטיפול שלהם דורשת ייצוב ותמיכה לשמירה על תנוחה נכונה בישיבה. פעולת ייצוב מסוג זה תבוצע ע"פ החלטת אחות מוסמכת אחראית משמרת. הפעולה תבוצע באמצעות סדין הקושר את גוף המטופל אל משענת הכורסא או במתקנים המיועדים לשמירת יציבות זמנית.

הגבלה זו לא תאריך מעבר לשעתיים.

8.6.2. היה וייצוב ישיבה זה מגביל את החולה בתנועותיו, על האחות המוסמכת אחראית המשמרת:

- להסביר ולהדריך את החולה/משפחתו
- לקבל הסכמת החולה לקשירה (מספיקה הסכמה בע"פ)
- לבצע אומדן (הכרה, תנוחה, הצורך בהמשך ההגבלה, מצב העור במקום החיכוך)
- לנמק את הסיבות להחלטה
- לפרט את האמצעים להגבלה
- לתעד ברשומת המטופל
- במקרים שההגבלה מתארכת מעבר לשעתיים, תנהג האחות כמפורט בסעיף 8.5
- האחות תאפשר לחולה תנוחה נוחה פיסיוולוגית בטיחותית, כולל תמיכת רגליים.

8.7. מעקב והשגחה

8.7.1. אחראית המשמרת תבצע הערכה של הצורך במשך זמן ההגבלה.

8.7.2. האחות המופקדת על הטיפול בחולה תבטיח מילוי צרכיו הבסיסיים, תבצע אומדן סיעודי לגבי תנוחה, נוחות, מצב העור במקום הקשירה, מצב הגפיים ומצבו הנפשי.

8.8. התרת חולה מהגבלה פיזית

- 8.8.1. התרה זמנית - לשם ביצוע טיפולים שוטפים.
- 8.8.2. רופא ו/או אחות מוסמכת אחראית משמרת רשאים להחליט על התרה זמנית או מלאה לפני שפג תוקף משך ההוראה, וזאת על סמך הערכת מצב המטופל.
- 8.8.3. במידה והחליטה האחות מוסמכת אחראית משמרת להתיר את המטופל, עליה לידע בהקדם את הרופא ולתעד את ההחלטה ברשומת המטופל.

8.9. רישום ותיעוד

כל הליך ההגבלה הפיזית יתועד וייחתם ברשומת המטופל, החל מההחלטה על ההגבלה, מתן ההוראה לביצוע ועד להתרת החולה. התיעוד יכלול:

- שם נותן ההוראה חתימתו וחותמתו
- תאריך ושעת מתן ההוראה
- הסיבות שהביאו להחלטה בדבר ההגבלה הפיזית
- אופן ההגבלה הפיזית ואמצעי הזהירות שיש לנקוט
- זמן תחילת הביצוע ומשך ההגבלה (עד 8 שעות)
- תיעוד ההסבר לחולה ו/או למשפחתו או אחר משמעותי
- טיפולים / אומדנים בזמן ההגבלה, מצב הגפיים והעור במקום הקשירה, לפני, בזמן ובתום ההגבלה
- שם וחתימת מבצע ההגבלה

9. הכשרה והטמעה

- 9.1. הנוהל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 9.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 9.3. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

10. בקרה

בקרה מדגמית על יישום הנוהל תבוצע באופן תקופתי על פי תכניות העבודה של הנהלת הדסה ו/או תכניות העבודה של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות.

מהדורת הנוהל	תאריך פרסום	עדכוני הנוהל
שישית	נובמבר 2024	עדכון סעיף 6.1.6
		איחוד סעיפים 8.1-8.2
		עדכון 8.1.4
		תוספת סעיפים 8.3.8, 8.3.16
		ביטול סעיף 8.5.2 במקומו נספו סעיפים 8.4.2-8.4.3
		תוספת מסמכים 1-2 , ביטול נספחים קודמים.

היסטורית כתיבה ואישור הנוהל

מהדורה	תאריך פרסום	כותבי ומעדכני הנוהל	אישורי הנוהל
ראשונה עד רביעית		לא ידוע	
חמישית	ספטמבר 2018	מרב יוסף מרכזת תחום נהלים מוסדית וכלל ארגונית	דר' רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות